



REUMON

NA MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO

Nome no médico, MD

Especialidade médica

nomedomédico@gmail.com



As formulações tópicas podem proporcionar **elevadas concentrações analgésicas** no local da inflamação, minimizando o risco associado às concentrações sistêmicas.

Após a aplicação tópica, as concentrações atingidas nos meniscos ou na cartilagem podem ser **4 a 7 vezes maiores** do que após a administração de AINE oral e as alcançadas nas bainhas dos tendões são várias centenas de vezes superiores às plasmáticas.

Chegar ao local da inflamação

LÍQUIDO SINOVIAL

MEMBRANA SINOVIAL

CARTILAGEM

CÁPSULA ARTICULAR

OSSO SUBCONDRA



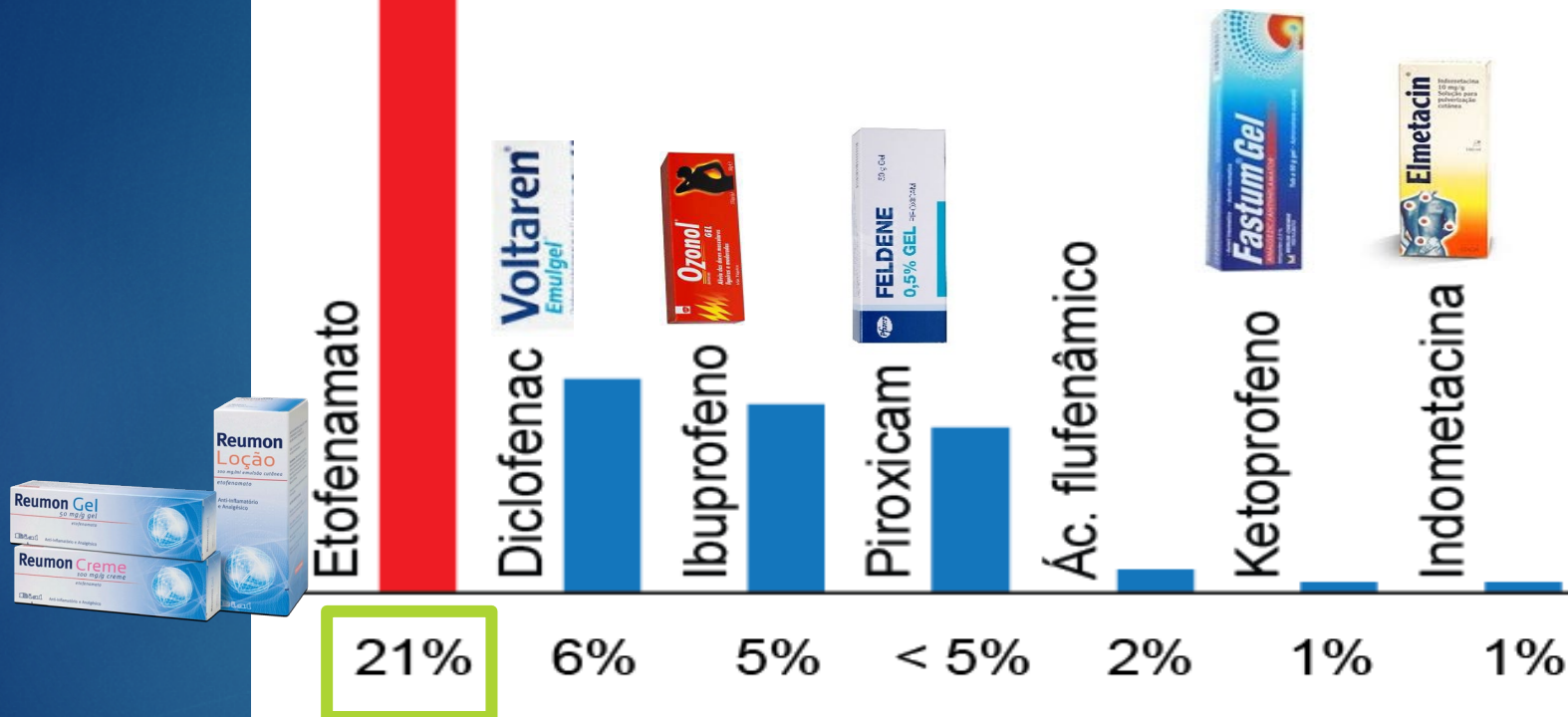
blaus



***Os AINE tópicos
não são todos iguais !***

REUMON

A biodisponibilidade do etofenamato após aplicação tópica é **3X superior** à dos restantes AINE tópicos.



A biodisponibilidade refere-se à **extensão** e à **velocidade** do fármaco em atingir o seu local de ação.

8 em cada 10 utentes recuperam funcionalidade com REUMON?

Tratamento de **300 doentes** com traumatismos fechados dos tecidos moles e articulações, com Reumon. A sensibilidade muscular, a dor espontânea, a dor em movimento, o edema e a limitação funcional das articulações afetadas, foram avaliados como parâmetros clínicos de acordo com a gravidade (0 a 3) após um período de tratamento de 6 a 12 dias. Houve uma rápida melhoria nos resultados em quase todos os doentes e foi recuperada a funcionalidade total das articulações afetadas durante o período do tratamento em 86% dos doentes.

Redução dos AINE orais como resultado da associação com o tratamento tópico

Um estudo avaliou a possibilidade de redução dos AINE orais como resultado de um tratamento combinado com REUMON (etofenamato) gel em **3584 doentes**.

O tratamento dirigiu-se principalmente a patologias tais como a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, a osteoartrose e a espondilose.

Num período inicial do ensaio de 1 a 2 semanas, foi administrado um AINE oral numa dosagem constante. Num segundo período de estudo, os doentes receberam também REUMON (etofenamato) gel a 5% quatro vezes por dia, em média (dose diária de 600 mg de REUMON (etofenamato)). Ao mesmo tempo, a dose de AINE oral foi gradualmente reduzida tanto quanto possível.

Redução dos AINE orais como resultado da associação com o tratamento tópico

RESULTADOS:

A dose de AINE oral foi significativamente reduzida como resultado da utilização adicional de etofenamato gel.

No decurso do ensaio a utilização de REUMON-GEL permitiu a diminuição da medicação oral em cerca de 40% nas doenças reumáticas inflamatórias, em cerca de 50% nas degenerativas e em mais de 50% nas afecções das partes moles.

Os efeitos adversos diminuíram claramente com o tratamento de combinação.



A melhoria ou desaparecimento das reações adversas envolvendo o trato gastrointestinal foram bastante significativos (21,9%).

A redução de 10% nos efeitos secundários do sistema nervoso central foi também significativa.

FARMACOCINÉTICA

BIODISPONIBILIDADE

21%

**LIGAÇÃO PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS**

98 – 99%

$t_{1/2}$

3,3 horas

ELIMINAÇÃO

**35% renal
>60% via biliar/fecal**

Os dados disponíveis apoiam a eficácia dos AINE tópicos no alívio da dor em **patologia musculoesquelética aguda**, como entorses, distensões ou lesões desportivas, bem como na **osteoartrite de articulações localizadas superficialmente**.

Os AINE tópicos, usados conforme necessário ou diariamente, podem **proporcionar benefícios de longo prazo na OA do joelho** quando combinados com medidas não farmacológicas.

Em estudos realizados na vida real, **AINE tópicos e orais** mostram um **efeito equivalente** na OA do joelho ao longo de um ano de tratamento. Uma revisão comparativa encontrou uma eficácia semelhante para os AINE tópicos e os orais.



- A **American Academy of Orthopaedic Surgeons** incluiu os AINE tópicos nas normas de tratamento da OA do joelho.
- A norma do **National Institute for Health and Care Excellence** (NICE) recomenda os AINE tópicos antes de iniciar tratamento com AINE orais como terapêutica de primeira linha na OA da mão e do joelho.
- Na norma do **American College of Rheumatology** os AINE tópicos são fortemente recomendados para tratamento da OA do joelho.
- O algoritmo de tratamento da **European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis** (ESCEO) recomenda os AINE tópicos como uma opção de tratamento precoce para o tratamento sintomático de OA do joelho e da mão.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

REUMON



NEVRALGIAS

Síndrome cervical
Lombalgias
Ciatalgias



ARTROPATIAS

Periartrite
Artrite / Poliartrite
Osteoartrose
Espondilose



TENDO E BURSOPATIAS

Bursites
Tenossinovites
Fibrosites



AFEÇÕES MUSCULARES

Mialgias



TRAUMATISMO

Contusões
Entorses
Distensões (ex: traumatismos desportivos)

FORMULAÇÕES ADAPTADAS A DIFERENTES NECESSIDADES

REUMON



Grande mais-valia da loção na em contexto de fisioterapia e sempre que é necessária a massagem.



APLICAÇÃO DE ETOFENAMATO POR IONTOFORESE

A treatment period of 10 (to 12) minutes and a current intensity of 0.3 - 2.0 mA /10 cm² electrode surface has proved useful for iontophoresis with etofenamate. The current strength used depends on the subjective experience of the patient.

In order to achieve optimum success, etofenamate should be applied underneath the **negative electrode**.

FORMULAÇÕES ADAPTADAS A DIFERENTES NECESSIDADES

REUMON



Absorção rápida



Sempre que é necessário fazer oclusão





Obrigado.

Nome no médico, MD

Especialidade médica

nomedomédico@gmail.com